

Sujet N 8

BRONCHIOOLITE

DU NOURRISSON

Pr Chokri Chouchane

OBJECTIFS

1. **Définir** la bronchiolite du nourrisson.
2. Citer les **principaux virus responsables** de la bronchiolite.
3. Etablir le **Dg positif** d'une bronchiolite a partir des données de l'anamnèse, de l'examen physique et de la Rx du thorax.
4. Reconnaître sur les données de l'anamnèse et de l'examen physique les **critères d'hospitalisation** d'une bronchiolite.

OBJECTIFS

5. Identifier par l'anamnèse et l'examen physique les **critères de gravité** d'une bronchiolite.
6. Distinguer une bronchiolite des **autres causes** de dyspnée aiguë du nourrisson.
7. Décrire les principes de la **prise en charge thérapeutique** de la bronchiolite.
8. Citer les **complications** aiguës de la bronchiolite
9. Décrire les **moyens de prévention** de la bronchiolite.

INTRODUCTION-DEFINITION (OBJECTIF 1)

INTRODUCTION –DEFINITION (objectif 1)

1-Parmi les caractéristiques de la bronchiolite on retient :

- A. Infection virale des voies respiratoires inférieures
- B. Infection virale des voies respiratoires supérieures
- C. Premier épisode de dyspnée sifflante avant l'âge de 24 mois
- D. Premier épisode de dyspnée sifflante avant l'âge de 12 mois
- E. Le Dg repose sur la clinique et la Rx du thorax

INTRODUCTION –DEFINITION (objectif 1)

- ❖ La bronchiolite est une infection virale des **VRI** du nourrisson.
- ❖ Le diagnostic est retenu devant **un premier épisode de dyspnée sifflante** chez un nourrisson de **moins de 1 an**.
- ❖ La notion de **contage viral** est souvent retrouvée à l'interrogatoire des parents.
- ❖ Le diagnostic est **exclusivement clinique**.
- ❖ Les situations d'urgence sont liées à la **sévérité des symptômes** et aux risques liés au **terrain**.
- ❖ L'attitude thérapeutique repose avant tout sur des mesures **symptomatiques**.

EPIDEMIOLOGIE (OBJECTIF 2)

EPIDEMIOLOGIE (OBJECTIF 2)

2- Parmi les virus responsables de de la bronchiolite on retient :

- A. Le métapneumovirus
- B. Le coronavirus
- C. L'entérovirus
- D. Le Bocavirus
- E. Le rotavirus

EPIDEMIOLOGIE (OBJECTIF 2)

- ❖ Le **VRS** est l'agent infectieux principal (70-80 %).
- ❖ D'autres virus peuvent être identifiés, notamment le:
 - **Rhinovirus,**
 - Virus **influenzae** (virus de la grippe),
 - Virus **parainfluenzae,**
 - **Metapneumovirus,**
 - **Coronavirus,**
 - **Bocavirus,**
 - **Adenovirus.**
- ❖ Une coïnfection virale peut se voir dans 20% des cas.

DIAGNOSTIC POSITIF (OBJECTIF 3)

DIAGNOSTIC POSITIF (OBJECTIF 3)

3- Parmi les signes cliniques de la bronchiolite on retient :

- A. Polypnée
- B. Wheezing
- C. Refus alimentaire
- D. Signes de lutte
- E. Stridor

DIAGNOSTIC POSITIF (OBJECTIF 3)

- ❖ Une phase prodromique (1-3 jours) : Rhinorrhée, toux sèche, fièvre modérée.
- ❖ Une phase d'état :
 - Température normale ou peu élevée,
 - Polypnée.
 - Chez le nouveau-né et le jeune nourrisson on peut voir des apnées,
 - Freinage expiratoire (temps d'expiration augmenté),
 - les râles sibilants parfois audibles à distance (wheezing)
 - les râles crépitants et/ou sous-crépitanants

DIAGNOSTIC POSITIF (OBJECTIF 3)

4- Parmi les indications de la Rx du thorax dans la bronchiolite on retient :

- A. Fièvre à 40 °C
- B. Suspicion de myocardite
- C. Suspicion de trouble de la ventilation
- D. Persistance des symptômes après 5 à 7 j d'évolution d'une bronchiolite
- E. Hyperleucocytose à prédominance PNN

DIAGNOSTIC POSITIF (OBJECTIF 3)

Les indications de la radiographie du thorax

- Signes de **sévérité** clinique
- Suspicion d'un **diagnostic différentiel** (Myocardite...),
- Suspicion de **complications** (surinfection ou troubles de la ventilation),
- **Persistance des symptômes** après 5 à 7 j d'évolution d'une bronchiolite initialement « banale ».

DIAGNOSTIC POSITIF (OBJECTIF 3)

5- Parmi les signes radiologiques de la bronchiolite on retient :

- A. Cardiomégalie
- B. Hyperclarté des deux champs pulmonaires
- C. Elargissement des espaces intercostaux
- D. Abaissement des coupes diaphragmatiques
- E. Images aréolaires

DIAGNOSTIC POSITIF (OBJECTIF 3)

SIGNES RADIOGRAPHIQUES DE LA BRONCHIOLITE :

❖ Distension thoracique :

- hyperclarté des deux champs pulmonaires,
- élargissement des espaces intercostaux, horizontalisation des côtes,
- abaissement des coupes diaphragmatiques,
- souvent un coeur de petit volume.

❖ Troubles de la ventilation

EVALUATION DE LA GRAVITE (OBJECTIF 5)

EVALUATION DE LA GRAVITE(OBJECTIF 5)

6- Parmi les critères de la bronchiolite modérée on retient :

- A. Fréquence respiratoire entre 60 et 69 c/min
- B. Fréquence cardiaque à 160 bat/min
- C. Saturation d'oxygène à l'air ambiant à 91%
- D. Déshydratation stade 1
- E. Etat général conservé

CRITÈRES D'HOSPITALISATION (OBJECTIF 4)

CRITÈRES D'HOSPITALISATION (OBJECTIF 4)

7- Parmi les critères d'hospitalisation d'un nourrisson atteint de bronchiolite on retient:

- A. Âge < 8 semaines
- B. Dysplasie bronchopulmonaire
- C. FR > 60/min chez le nouveau-né
- D. Saturation transcutanée en oxygène < à 92 %
- E. Difficultés de prendre la tétée ou le biberon

CRITÈRES D'HOSPITALISATION (OBJECTIF 4)

- ❖ Terrain
- ❖ Sévérité clinique
- ❖ Conditions socio-économiques ou d'environnement défavorables

DIAGNOSTICS DIFFERENTIELS (OBJECTIF 6)

DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS (OBJECTIF 6)

8- Parmi les diagnostics différentiels de la bronchiolite on retient :

- A. La coqueluche
- B. La mucoviscidose
- C. Laryngite aiguë
- D. Canal atrioventriculaire (CAV)
- E. Les myocardites infectieuses

DIAGNOSTICS DIFFERENTIELS (OBJECTIF 6)

- ❖ La coqueluche
- ❖ Les cardiopathies congénitales avec shunt gauche-droit :
 - Communication interventriculaire (CIV),
 - Canal atrioventriculaire (CAV),
 - Persistance du canal artériel (PCA),
- ❖ Les myocardites infectieuses,
- ❖ les troubles du rythme cardiaque (notamment les TSV).

PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE (OBJECTIF 7)

PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE(OBJECTIF 7)

9- Parmi les moyens thérapeutiques de la bronchiolite on retient :

- A. La désobstruction rhinopharyngée
- B. Le couchage en proclive dorsal à 20°
- C. Un apport hydrique de 90 à 120 ml/kg/jour
- D. Traitement antipyrétique en cas de fièvre $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$
- E. Oxygénothérapie si la $\text{SpO}_2 < 94 \%$

PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE(OBJECTIF 7)

TRAITEMENTS SYMPTOMATIQUES

- ❖ **Désobstruction rhinopharyngée est essentielle + + + +**
- ❖ **Le couchage en proclive dorsal à 30°**
- ❖ **Hydratation suffisante pour fluidifier les sécrétions : 90 à 120 ml/kg/j**
- ❖ **Aération correcte de la pièce**
- ❖ **Traitement antipyrétique si fièvre $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ou fièvre mal tolérée.**
- ❖ **L'oxygénothérapie** : indiquée si la $\text{SpO}_2 < 92\%$
- ❖ Si le nourrisson a une Insuffisance respiratoire aiguë (IRA) un recours aux techniques d'assistance respiratoire (OHD, VNI ou VA) est indiqué.

PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE(OBJECTIF 7)

10- Parmi les traitements médicamenteux de la bronchiolite on retient :

- A. Nébulisations des beta2mimétiques
- B. Nébulisations du sérum salé hypertonique
- C. Antitussifs
- D. Antibiothérapie si surinfection bactérienne documentée
- E. Corticothérapie systématique

EVOLUTION- COMPLICATIONS (OBJECTIF 8)

EVOLUTION- COMPLICATIONS (OBJECTIF 8)

11- Parmi les éléments de surveillance du nourrisson hospitalisé pour bronchiolite on retient :

- A. Température
- B. Fréquence cardiaque
- C. Etat de conscience
- D. Gaz du sang
- E. Etat hydratation

EVOLUTION- COMPLICATIONS (OBJECTIF 8)

12- Parmi les complications aiguës de la bronchiolite on retient :

- A. Les apnées
- B. La déshydratation
- C. Le pneumomédiastin
- D. L'Insuffisance cardiaque
- E. La bronchiolite oblitérante

EVOLUTION- COMPLICATIONS (OBJECTIF 8)

LES COMPLICATIONS AIGUES SONT:

- ❖ Les apnées
- ❖ L'insuffisance respiratoire aigue
- ❖ Les surinfections bactériennes
- ❖ L'atélectasie
- ❖ Déshydratation
- ❖ Pneumomédiastin, Pneumothorax

EVOLUTION- COMPLICATIONS (OBJECTIF 8)

13- Parmi les bactéries de surinfection des bronchiolites on retient :

- A. *Mycoplasma pneumoniae*
- B. *Haemophilus influenza*
- C. *Moraxella catarrhalis*
- D. *Staphylococcus aureus*
- E. *Streptococcus pneumoniae*

EVOLUTION- COMPLICATIONS (OBJECTIF 8)

14- Les principaux agents infectieux responsables de la bronchiolite oblitérante sont :

- A. L'adénovirus
- B. Le bocavirus
- C. Le métapneumovirus
- D. Le virus influenza
- E. Le virus parainfluenza

PREVENTION DE LA BRONCHIOLITE (OBJECTIF 9)

PREVENTION DE LA BRONCHIOLITE (OBJECTIF 9)

15- Parmi les moyens de prévention de la bronchiolite on retient :

- A. Lavage des mains
- B. L'allaitement maternel
- C. Antibioprophylaxie
- D. Isolement
- E. Vaccination

PREVENTION DE LA BRONCHIOLITE (OBJECTIF 9)

LES MOYENS DE PRÉVENTION

❖ Mesures générales :

- Lavage des mains
- Port du masque
- Proscrire le tabagisme passif et éviter la garde en collectivité des nourrissons atteints
- Informations sur le mode de contamination ;
- Pas de bisous
- Encourager l'allaitement maternel et sa prolongation
- Isolement
- Décontamination quotidienne des objets et des surfaces en collectivité.

❖ Mesures spécifiques en milieu hospitalier :

- Mise en place d'un « plan bronchiolite » dans les services de pédiatrie ;
- Port du masque pour le personnel soignant, lavage des mains, surblouse, matériels à usage unique.

PREVENTION DE LA BRONCHIOLITE (OBJECTIF 9)

16- Le traitement préventif de la bronchiolite à VRS par le le Palivizumab (Synagis®) est indiqué chez :

- A. Les nourrissons prématurés ≤ 35 SA, d'âge < 6 mois
- B. Les enfants ≤ 2 ans et ayant une dysplasie broncho-pulmonaire
- C. Les enfants ≤ 2 ans et ayant une cardiopathie congénitale avec un retentissement hémodynamique.
- D. Les enfants ≤ 2 ans et ayant un déficit immunitaire
- E. Les enfants ≤ 2 ans et ayant une mucoviscidose

CAS CLINIQUE

CAS CLINIQUE

Nourrisson âgé de 8 mois sans antécédents pathologiques notables admis pour dyspnée évoluant depuis 2 jours.

A l'examen clinique :

- Température 38,2 °C
- Fréquence respiratoire 63 cycles/min
- Fréquence cardiaque 130 bat/min
- Saturation de l'oxygène 86% à l'air ambiant
- Tirage Inter costal, battement des ailes du nez
- Cyanose péribuccale
- Râles sibilants

CAS CLINIQUE

Nourrisson âgé de 8 mois sans antécédents pathologiques notables admis pour **dyspnée** évoluant depuis 2 jours.

A l'examen clinique :

- Température **38,2 °C**
- Fréquence respiratoire **63 cycles/min**
- Fréquence cardiaque **130 bat/min**
- **Saturation de l'oxygène 86% à l'air ambiant**
- **Tirage Inter costal modéré, battement des ailes du nez**
- **Cyanose péribuccale**
- **Râles sibilants**

CAS CLINIQUE

1- Quel est votre diagnostic ?

- A. Bronchiolite
- B. Dysplasie broncho-pulmonaire
- C. Cardiopathie congénitale
- D. Pneumonie
- E. Staphylococcie pleuropulmonaire.

CAS CLINIQUE

2- Vous avez demandé une radiographie du thorax devant :

- A. Température 38,2 °C
- B. Fréquence respiratoire 63 cycles/min
- C. Fréquence cardiaque 130 bat/min
- D. Saturation de l'oxygène 86% à l'air ambiant
- E. Cyanose péribuccale

CAS CLINIQUE

3- L'hospitalisation a été indiquée devant :

- A. Température 38,2 °C
- B. Fréquence respiratoire 63 cycles/min
- C. Fréquence cardiaque 130 bat/min
- D. Saturation de l'oxygène 86% à l'air ambiant
- E. Cyanose péribuccale

CAS CLINIQUE

4- Quelle est votre attitude thérapeutique ?

- A. Désobstruction rhinopharyngée
- B. Nébulisations du sérum salé hypertonique
- C. Apport hydrique de 90 à 120 ml/kg/jour
- D. Traitement antipyrétique
- E. Oxygénothérapie

CAS CLINIQUE

Au 4ème jour d'hospitalisation le nourrisson a présenté une fièvre à 40°C, augmentation des besoins en oxygène.

5- Quelle est votre attitude ?

- A. Radiographie du thorax de face
- B. CRP
- C. NFS
- D. Nébulisations des beta2mimétiques
- E. Antibiothérapie par voie générale

CAS CLINIQUE

6- Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Pneumothorax
- B. Pneumomédiastin
- C. Pleurésie
- D. Surinfection bactérienne
- E. Myocardite

Any
Questions